

Diabetes gestacional

Cornerstones4Care™

¿Qué es la diabetes gestacional?

La diabetes gestacional es un nivel alto de azúcar en la sangre que se desarrolla durante el embarazo. El nivel de azúcar en la sangre generalmente regresa a la normalidad después de nacer el bebé.

¿Qué causa la diabetes gestacional?

Cuando usted come, algunos alimentos se convierten en azúcar (también llamada glucosa). El azúcar viaja en su sangre a todas las células de su cuerpo. La insulina ayuda al azúcar a moverse de su sangre a sus células. La insulina es una hormona producida por las células beta en su páncreas.

Sus células necesitan azúcar para generar energía. El azúcar de los alimentos hace que su nivel de azúcar en la sangre suba. El azúcar de los alimentos puede ser azúcar en sí misma o puede provenir de los carbohidratos que el cuerpo transforma en azúcar. La insulina baja su nivel de azúcar en la sangre al ayudar a que el azúcar se mueva de su sangre a sus células.

Si usted tiene diabetes gestacional, las hormonas del embarazo aumentan sus niveles de azúcar en la sangre para satisfacer las necesidades de crecimiento de su bebé.

Su cuerpo trata de producir más insulina para manejar el azúcar adicional, pero todavía no es suficiente. Así que el azúcar se queda en su sangre en vez de moverse a sus células. Por eso su nivel de azúcar en la sangre sube demasiado.

¿Cuáles son los riesgos de la diabetes gestacional?

Si los niveles de azúcar en la sangre no se controlan durante el embarazo, esto puede causar problemas tanto para usted como para su bebé. Su bebé recibe nutrientes, incluyendo azúcar, de su sangre. Si sus niveles de azúcar en la sangre están altos, su bebé recibirá demasiado azúcar. Mucha azúcar no es buena para su bebé. El o ella almacenará el azúcar adicional en forma de grasa. El bebé puede aumentar mucho de peso y ser demasiado grande.

Si usted tiene diabetes gestacional, su bebé tiene un riesgo mayor de:

- Lesiones durante el parto
- Niveles bajos de azúcar después de nacer
- Problemas respiratorios
- Ictericia
- Problemas de desarrollo
- Diabetes tipo 2 más adelante en su vida

La diabetes gestacional puede aumentar para usted el riesgo de:

- Diabetes tipo 2
- Presión sanguínea alta durante el embarazo
- Cesárea
- Diabetes gestacional si tiene otro embarazo

¡Pero estos problemas no tienen que ocurrir! Controlar sus niveles de azúcar en la sangre puede ayudar a reducir el riesgo.

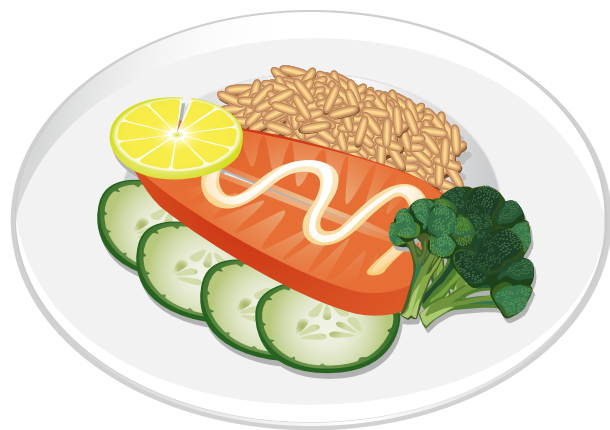


Diabetes gestacional

Cómo controlar la diabetes gestacional

Su meta al controlar la diabetes gestacional es mantener sus niveles de azúcar en la sangre tan cerca de lo normal como sea posible. Su médico le ayudará a preparar un plan de cuidado para cumplir con esa meta. Para ayudar a controlar su azúcar en la sangre, usted necesita:

- Ingerir sus comidas y meriendas de acuerdo con su plan de comida
- Hacer actividad física con regularidad
- Tomar sus medicamentos como se los recetó su médico
- Revisar con frecuencia su azúcar en la sangre, de acuerdo con su plan de cuidado



Qué esperar después del nacimiento

Su médico revisará su azúcar en la sangre de 6 a 12 semanas después del nacimiento del bebé para asegurarse de que esté normal. Debido a la diabetes gestacional, usted tiene un riesgo mayor de desarrollar diabetes más tarde en su vida. Así que su médico puede recomendarle que continúe revisando su azúcar en la sangre. Usted puede reducir su riesgo de desarrollar diabetes gestacional o diabetes tipo 2 si:

- Continúa comiendo una dieta saludable
- Hace actividad física con regularidad
- Controla su peso

Pregunte a su médico qué puede hacer para mantenerse saludable, ¡por usted y por su bebé!

Para más información, visite
Cornerstones4Care.com

Novo Nordisk Inc. autoriza la reproducción de este material sólo para fines educativos sin lucro con la condición de que se conserve este material en su formato original y se muestre el aviso sobre derechos reservados. Novo Nordisk Inc. se reserva el derecho de revocar este permiso en cualquier momento.

Cornerstones4Care™ es una marca comercial de Novo Nordisk A/S.

© 2013 Novo Nordisk Todos los derechos reservados. 0313-00014232-1 Abril de 2013 Cornerstones4Care.com



SU CONSEJERO American Diabetes Association. DE DIABETES

A1C/eAG

¿QUÉ ES A1C?

El A1C es una prueba de glucosa en la sangre que también puede denominarse promedio aproximado de glucosa (en inglés conocido como estimated average glucose o eAG).⁰ Indica el promedio de glucosa en la sangre durante los últimos dos o tres meses. Hace esto midiendo cuánta glucosa se adhiere a los glóbulos rojos. Debido a que siempre se producen glóbulos rojos nuevos para sustituir los viejos, el A1C puede variar con el tiempo con los cambios en el nivel de glucosa en la sangre.

¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBO HACERME LA PRUEBA A1C/EAG?

Recuérdale a su equipo de atención médica que le mida el A1C por lo menos dos veces al año. Si está cambiando de medicamentos o haciendo otros cambios en su cuidado, es posible que deba hacerse la prueba con más frecuencia.

¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DESEADOS DE A1C/EAG?

El objetivo general para A1C de la Asociación es 7% (eAG de 154 mg/dl). Es posible que su médico le recomiende un nivel más alto o bajo según su edad y otros factores. Sea cual sea su número, cuanto más se acerque a resultados de menos de 7%, mayor su probabilidad de prevenir o retrasar problemas a largo plazo como ceguera. Los estudios indican que por cada punto en que disminuye su nivel de A1C, se reduce en 40 por ciento el riesgo de complicaciones de la diabetes a largo plazo.

¿QUÉ SIGNIFICAN MIS RESULTADOS DE A1C/EAG?

Por lo general sus resultados de A1C reflejan las tendencias generales, que verá en sus mediciones diarias de glucosa en la sangre. Sin embargo, a veces, sus resultados de A1C pueden parecer más altos o bajos de lo esperado. Eso quizá se deba a que no está midiéndose el nivel de glucosa en la sangre cuando está muy alto o bajo.

Para interpretar sus resultados, primero busque su porcentaje de A1C en la columna de la izquierda. Luego lea en el lado opuesto su nivel promedio de glucosa en la sangre durante los últimos dos o tres meses.

6%	126 mg/dl	8.5%	197 mg/dl
6.5%	140 mg/dl	9%	212 mg/dl
7%	154 mg/dl	9.5%	226 mg/dl
7.5%	169 mg/dl	10%	240 mg/dl
8%	183 mg/dl	10,5%	255 mg/dl

Si su A1C/eAG no es lo que esperaba, hable con su proveedor de servicios médicos.

¿DE TODOS MODOS DEBO MEDIRME LA GLUCOSA CON UN MEDIDOR SI ME HAGO LA PRUEBA A1C/EAG CON FRECUENCIA?

Ambos tipos de pruebas son importantes. Usted usará los resultados de su medidor para tomar decisiones día tras día. La prueba A1C le da una idea general de lo que sucede.

Para obtener más información, visite diabetes.org/espanol o llame al 1-800-DIABETES

Ejercicio

Los médicos recomiendan que todos los adultos (entre ellos, las mujeres embarazadas) hagan al menos 30 minutos de ejercicio todos o casi todos los días de la semana.

El ejercicio aporta muchos beneficios durante el embarazo. Puede ser positivo para el ánimo, el nivel de energía y el sueño. También puede ayudar con síntomas del embarazo tales como el estreñimiento, la hinchazón abdominal, la inflamación y el dolor de espalda.

El tipo de ejercicio adecuado para usted depende de su embarazo actual, de sus embarazos anteriores y de su nivel de actividad anterior al embarazo.

En general, los médicos recomiendan caminar y nadar como buenos ejercicios para las embarazadas. Las mujeres embarazadas deben evitar actividades en las que podrían caerse fácilmente o lastimarse el área del estómago; por ejemplo, hockey, fútbol, básquetbol, equitación, esquiar en descenso y gimnasia artística.

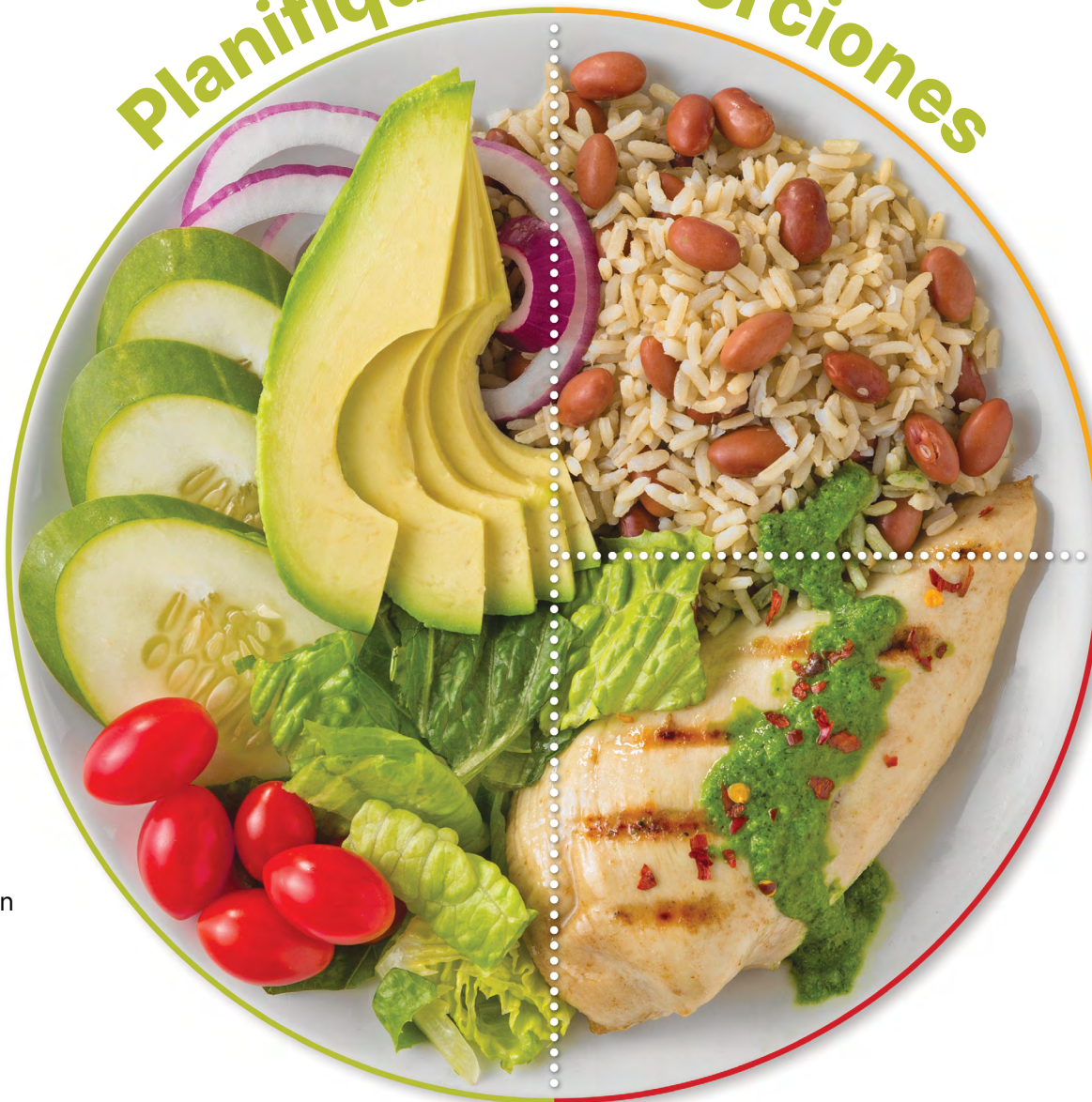
Para hacer ejercicio con seguridad, debe:

- Evitar recostarse boca arriba (después de los primeros tres meses de embarazo)
- Comenzar de a poco y aumentar gradualmente el nivel de actividad
- Evitar hacer ejercicio si el clima está caluroso o húmedo
- Beber mucha agua
- Usar un sostén que sujete bien los senos
- Dejar de hacer ejercicio si se queda sin aire y no puede hablar fácilmente

Debe dejar de hacer ejercicio e informar a su médico o partera si tiene alguno de los siguientes síntomas:

- Sangrado de la vagina
- Dificultad para respirar
- Sensación de mareo
- Dolor de cabeza o dolor en el pecho
- Debilidad muscular
- Contracciones
- Líquido que sale de la vagina
- Inflamación, dolor, enrojecimiento o calor en las piernas
- Siente que el bebé no se mueve como siempre

Planifique sus Porciones



Agua o Bebidas
de 0 Calorías

Este plato incluye ensalada verde con tomates, pepino, cebolla y aguacate, arroz con frijoles y pollo asado.

Busque más recursos
para la planificación
de comidas.



diabetesfoodhub.org



Utilice un plato de 9 pulgadas para ayudarle a servir porciones inteligentes.

Este mantel individual ha sido reformateado desde su diseño original. La financiación para este rediseño ha sido posible gracias a una subvención educativa restringida de Abbott Diabetes Care. Para obtener más manteles, visite ShopDiabetes.org.

¡En tu marca, listo, empieza a contar!

Recuento de carbohidratos — un método para ayudarte a controlar la glucosa en la sangre

Si padeces de diabetes, mantener la glucosa en la sangre en un rango saludable te puede ayudar a sentirte mejor hoy y en el futuro. El recuento de carbohidratos es un método flexible, no una dieta, que puedes usar para planificar tus comidas. Este método te podrá ayudar a entender cómo los diferentes tipos de alimentos afectan el nivel de glucosa en la sangre.

Los carbohidratos y la glucosa en la sangre

Cualquier carbohidrato que se consume (por ejemplo leche, fruta, pan y pasta) se convierte en glucosa, lo cual causa que el nivel de glucosa en la sangre se eleve. Sin embargo, el consumo de alimentos con carbohidratos a través del día es importante ya que éstos te proveen energía y nutrientes esenciales. Para el manejo efectivo de la glucosa en la sangre, los niveles de energía y el peso, presta atención a la cantidad de carbohidratos que consumes.

Mantener el equilibrio correcto entre los carbohidratos y la insulina (no importa si tu cuerpo la produce o la recibes con medicamentos) te ayudará a controlar tu nivel de glucosa en la sangre. La determinación de cuándo y cuánto comer - y si debes o no incluir tentempiés y meriendas, debe basarse en tu estilo de vida, medicamentos y metas de tu plan de alimentación. Un dietista nutricionista registrado (RDN, por sus siglas en inglés) puede considerar las siguientes maneras de usar el recuento de carbohidratos para establecer el plan más saludable para ti:

- ❖ **Control de las porciones:** Establecer una máxima cantidad de carbohidratos para cada comida dentro de tu plan de alimentación saludable y/o tomar medicamentos para la diabetes puede evitar que el nivel de glucosa en tu sangre sea demasiado elevado.

- ❖ **Consistencia:** Si usas medicamentos para la diabetes o insulina, puede ser importante consumir la misma cantidad de alimentos y carbohidratos a la misma hora todos los días. Esto puede hacer que tu nivel de glucosa en la sangre no suba o baje demasiado.
- ❖ **Flexibilidad:** Si tu plan de terapia incluye dosis variables de insulina de acuerdo a tu consumo de carbohidratos (índice carbohidrato/insulina), el recuento preciso de carbohidratos te puede ayudar a determinar la cantidad de insulina que debes tomar.

Alimentos que contienen carbohidratos

- ❖ Granos (por ejemplo, pan, galletas, arroz, cereales fríos y calientes, tortillas y fideos)
- ❖ Vegetales con almidón (por ejemplo papas, guisantes, maíz, calabaza, lentejas y frijoles)
- ❖ Frutas y jugos
- ❖ Leche y yogures
- ❖ Dulces y postres

Los vegetales sin almidón (tales como zanahorias, brócoli y tomates) contienen solamente una pequeña cantidad de carbohidratos y no afectan el nivel de glucosa en la sangre cuando se consumen en pequeñas porciones.

Opciones de carbohidratos y tamaño de porciones

- ❖ Una **“opción de carbohidratos”** es una porción de alimentos, tales como una rebanada de pan, que contiene 15 gramos de carbohidratos (1 opción de carbohidratos = 15 gramos of carbohidratos).
- ❖ El concepto es que el total de carbohidratos de cualquier alimento frecuentemente tiene un impacto similar sobre los niveles de glucosa en la sangre.
- ❖ Pequeñas porciones de dulces o azúcar se pueden consumir en vez de otros alimentos que contienen carbohidratos.
- ❖ Mide o pesa los alimentos para así aprender a estimar a la vista el tamaño de una porción de los alimentos comunes. Si no tienes una pequeña balanza o tazas medidoras a mano, usa estas ilustraciones como referencia.



1/2 taza



1 taza

Aprende a leer la etiqueta de datos nutricionales

Estos son consejos a tener en cuenta al leer las etiquetas. Recuerda: No te olvides comparar el tamaño de la ración en la etiqueta con la porción real que consumes.

1. Busca el tamaño por ración.

Nutrition Facts / Datos de Nutrición

Serving Size	15 crackers (30 g)
Tamaño de Ración	15 galletas (30 grs.)
Servings Per Container	about 14
Raciones por Envase	aprox. 14

3. Compara el tamaño de la ración en la etiqueta con la porción real que consumes.

2. Ubica el número total de carbohidratos en una ración (este número incluye los azúcares de modo que no tienes que contarlos por separado).

Calories / Calorías	130
Total Fat / Grasa Total 3g	5%
Saturated Fat / Grasa Saturada	0g
Cholesterol / Colesterol 0mg	0%
Sodium / Sodio 160mg	7%
Total Carbohydrate / Carbohidrato Total 22g	7%
Dietary Fiber / Fibra Dietética 2g	8%
Sugars / Azúcares 3g	
Protein / Proteínas 3g	—
Vitamin A / Vitamina A	0%
Vitamin C / Vitamina C	0%

4. Calcula los gramos de carbohidratos o las opciones de carbohidratos. En este ejemplo, 10 galletas saladas contienen unos 15 gramos de carbohidratos lo que es igual a una opción de carbohidratos.

Cómo buscar en línea las opciones de carbohidratos de los alimentos

1. Ubica el nombre de la compañía que produce o empaqua el alimento y visita su sitio web.
2. Busca un sitio web fiable que contenga información nutricional tal como los siguientes:
 - a. Calorie King (www.calorieking.com)
 - b. MyFoodAdvisor (<http://tracker.diabetes.org/explore>)
3. Visita el sitio web del restaurante de tu cadena favorito para que puedas mantenerte fiel a tu plan de alimentación cuando comas fuera de la casa.



El número de opciones de carbohidratos que necesitas depende de tu peso, tu nivel de actividad física y tus metas para controlar el peso. Un dietista nutricionista registrado (RDN) te puede ayudar a calcular la cantidad apropiada de carbohidratos que debes consumir. Para encontrar un dietista nutricionista registrado (RDN) en tu zona, visita el sitio web www.eatright.org

DIABETES-LISTADO DE ALIMENTOS SEGÚN SU IG

El índice glucémico (**IG**) se utiliza para valorar cómo afectan los alimentos que contienen hidratos de carbono en la sangre, es decir, cual es el nivel de glucosa en sangre al ingerir un determinado alimento.

Un IG **alto** es aquel que eleva rápidamente la glucosa en sangre: su valor es ≥ 70 y suelen ser los cereales, pan, arroz.



Un IG bajo es aquel que produce menores oscilaciones en la glucemia, siendo beneficioso para el manejo de la diabetes y la obesidad, y para los deportistas que deben realizar esfuerzos prolongados: su valor es ≤ 50 y suelen ser las legumbres, la pasta, la fruta y los lácticos.



IG de algunos alimentos	
Zanahorias cocidas	92
Miel	87
Puré de patatas instantáneo	80
Maíz en copos	80
Melón	76
Arroz blanco	72
Patatas cocidas	70
Pan blanco	69
Arroz integral	66
Palomitas de maíz	65
Pasas	64
Remolachas	64
Plátano	62
Maíz dulce	59
Pasteles	59
Cereales muesli	57
Copos de avena	55
Tortillas de maíz	52
Patatas fritas	51
Boniatos	51
Espaguetis	50
Zumo de naranja	43
Chocolate	40
Manzanas	39
Tomates	38
Garbanzos	36
Yogur	36
Leche entera	34
Leche desnatada	32
Lentejas	32
Judías	29
Ciruelas	25
Cerezas	23
Brotes de soja	15
Cacahuetes	13

Atkinson F. S., Brand-Miller J. C., Foster-Powell K.
"International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values"
DIABETES CARE, vol. 31, num12, diciembre; 2008

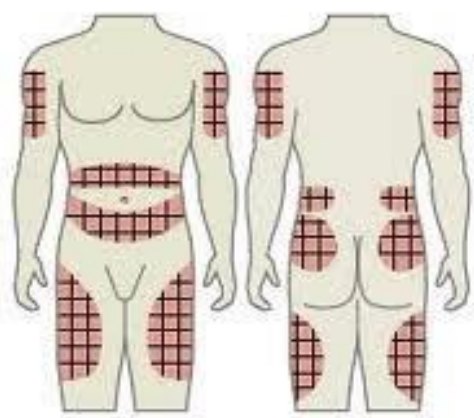
<u>Tipos de insulina</u>	<u>Qué tan rápido comienza a funcionar</u>	<u>Cuándo es mas efectivo</u>	<u>Cuánto dura</u>
Insulina de acción rápida <i>Inyecte de 5 a 10 minutos antes de comer</i> Incluye: Admelog, Apidra, Fiasp, Humalog, Novolog	15 minutos	30 a 90 minutos	3 a 5 horas
Insulina de acción intermedia <i>Inyecte dos veces al día o antes de acostarse</i> Incluye: Humulin N, Novolin N	1 a 3 horas	4-6 horas	12 a 15 horas
Insulina de acción prolongada <i>Inyecte una o dos veces al día; usualmente antes de dormir</i> Incluye: Basaglar, Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba	1 hora	estable; no hay cambio	20 a 26 horas

Usando una pluma de insulina

1. Retire la tapa, coloque la aguja de la pluma.
2. ** Si usa insulina turbia, mezcle bien la insulina antes de usarla rodando suavemente o sacudiendo.
3. Haz una dosis de prueba; marque 2 unidades y asegúrese de que salga una corriente de insulina. Repita si necesario.
4. Seleccione y limpie el sitio de inyección con alcohol y algodón.
5. Marque la dosis; inyecte lentamente en un ángulo de 90 grados, sostenga durante 5 segundos, luego retire la aguja.
6. Deseche la aguja y reemplace la tapa.
7. Deseche la pluma de insulina "nublado" de NPH después de 2 semanas, deseche otra insulina "clara" después de 4 semanas.

Usando una jeringa de insulina

1. Limpie la parte superior del frasco de insulina con alcohol y algodón.
2. ** Si usa insulina turbia, mezcle bien la insulina antes de usarla rodando suavemente o sacudiendo.
3. Seleccione la dosis en la jeringa tomando aire; inyecte aire en el frasco.
4. Con la jeringa todavía en el frasco, volteo el frasco boca abajo y mida la dosis de insulina.
5. Seleccione y limpie el sitio de inyección con alcohol y algodón.
6. Inyecte la dosis lentamente en un ángulo de 90 grados; retirar la aguja.
7. Deseche la aguja / jeringa en un envase de plástico duro.
8. Deseche los viales de insulina después de 4 semanas, cualquier tipo de insulina.



Zonas de aplicación de insulina

Signos de bajo nivel de azúcar en la sangre y cómo corregir:

Temblores	Sudores	Mareo o temblores	Hambre
Debilidad o cansancio		Ansiedad	
Dolor de cabeza		Nervioso o alterado	

1. Si tiene algún síntoma, revise su nivel de azúcar en la sangre.
2. Si es <70, come 15 gramos de carbohidratos. No tome bebidas azucaradas.
3. Revise el nivel de azúcar en la sangre en 15 minutos. Si aún está por debajo de <70, repita el proceso hasta que se suba >90. (Este proceso se llama "Rule of 15".)
4. Escriba una nota sobre su nivel bajo de azúcar en la sangre en su registro de azúcar en la sangre; envíe su registro a la oficina.
5. Siempre tenga su glucómetro y un bocado si está tomando insulina / medicamentos para la diabetes.

Síntomas de nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia)

Algunos síntomas:

Causas: Comer poco o saltar una comida; demasiada insulina o píldoras para la diabetes; estar más activo de lo usual.

Comienzo: Con frecuencia repentino.



TEMBLORES



PULSO ACELERADO



SUDOROSO



MAREADO O TEMBLOROSO



ANSIEDAD



HAMBRE



VISION BORROSA



DÉBIL O CANSADO



DOLORES DE CABEZA



NERVIOSO O ALTERADO

SI UN NIVEL BAJO DE AZÚCAR EN LA SANGRE NO SE TRATA, USTED PUEDE DESMAYARSE O REQUERIR ASISTENCIA MÉDICA.

¿Qué puede hacer?



REVISE de inmediato su azúcar en la sangre. Si no puede hacerse la prueba, trátese de todos modos.



TRÁTESE comiendo de 3 a 4 tabletas de glucosa o de 3 a 5 caramelos duros que pueda masticar con rapidez (como las mentas) o bebiendo 4 onzas de jugo de frutas o 1/2 lata de refresco de soda regular.



REVISE otra vez su azúcar en la sangre después de 15 minutos. Si todavía está baja, trátese otra vez. Si los síntomas no desaparecen, llame a su médico.

Para más información llame a la Línea de consejos de Novo Nordisk al 1-800-260-3730 o visítenos en la red en ChangingDiabetes-us.com/enEspañol.

Novo Nordisk Inc. autoriza la reproducción de este material sólo para fines educativos sin lucro con la condición de que se conserve este material en su formato original y se muestre el aviso sobre derechos reservados. Novo Nordisk Inc. se reserva el derecho de revocar este permiso en cualquier momento.

¿Tuvo diabetes gestacional cuando estaba embarazada?

Lo que usted necesita saber.

A algunas mujeres les da diabetes cuando están embarazadas. Esto es lo que los médicos llaman diabetes gestacional. La mayor parte del tiempo, este tipo de diabetes desaparece después de que nace su bebé. Pero aun si la diabetes se va, usted tiene una mayor probabilidad de desarrollar diabetes en el futuro. Su hijo también puede tener una mayor probabilidad de ser obeso y tener diabetes tipo 2 más adelante en la vida. Esta hoja de consejos le puede ayudar a saber lo que puede hacer por usted y su hijo.

Pasos que usted puede tomar

Hágase la prueba para la diabetes:

- ▶ Hágase la prueba para la diabetes entre 6 a 12 semanas después del nacimiento de su bebé. Si la prueba es normal, hágase la prueba cada 3 años. Si los resultados de las pruebas muestran que su nivel de azúcar en la sangre (glucosa) es más alto de lo normal pero no lo suficientemente alto como para ser diabetes, usted puede tener prediabetes. Si es así, usted debe hacerse la prueba para la diabetes cada año.
- ▶ Hable con su médico sobre los resultados de la prueba y lo que puede hacer para mantenerse saludable.
- ▶ Si usted tiene exceso de peso y los resultados de la prueba indican que podría tener diabetes, pregúntele a su médico qué cambios puede hacer para bajar de peso, y también pídale ayuda para lograr estos cambios. Es posible que tenga que tomar medicamentos como la metformina para prevenir la diabetes tipo 2.



National Diabetes Education Program

Un programa de los Institutos Nacionales de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Cambie los alimentos que come y sea más activa:

- ▶ Elija alimentos saludables, tales como:
 - Frutas frescas, congeladas o enlatadas en agua
 - Carnes con poca grasa, pollo y pavo sin el pellejo, y pescado
 - Leche, queso y yogur sin grasa o con poca grasa
 - Vegetales, granos enteros, alverjas y frijoles (no enlatados)
- ▶ Beba agua en lugar de jugo o soda regular.
- ▶ Coma cantidades más pequeñas de los alimentos para poder alcanzar y mantener un peso saludable. Por ejemplo, coma una hamburguesa de 3 onzas en lugar de una hamburguesa de 6 onzas. Tres onzas de carne es aproximadamente el tamaño de un puño o de un juego de naipes o barajas.
- ▶ Sea más activa cada día. Trate de hacer por lo menos 30 minutos de actividad física, 5 días a la semana. Puede dividir su actividad en periodos de 10 minutos a la vez, 3 veces al día. Camine con amigos, nade o haga jardinería para moverse más.
- ▶ Trate de volver a tener un peso saludable. Hable con su equipo de cuidados de la salud para hacer un plan que le ayude a bajar de peso lentamente. Tener un peso saludable puede ayudar a reducir las probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2.

Otros pasos que puede tomar

- ▶ Dígale a su médico o equipo de cuidados de la salud si usted:
 - tuvo diabetes gestacional
 - desea quedar embarazada otra vez
- ▶ Amamante a su bebé para ayudarle a usted a bajar de peso y mejorar la salud de su hijo.
- ▶ Asegúrese de que su historia de diabetes gestacional esté anotada en la historia médica de su hijo.



Pasos que puede tomar toda la familia

- ▶ Pídale a su médico un plan de alimentación o una dieta que ayude a sus hijos a crecer y a mantenerse en un peso saludable.
- ▶ Ayude a sus hijos a elegir alimentos saludables.
- ▶ Ayude a sus niños a estar activos por lo menos 60 minutos cada día.
- ▶ Hagan cosas juntos en familia, como preparar comidas saludables o jugar juegos activos.
- ▶ Limite a dos horas diarias la cantidad de tiempo que sus hijos juegan en la computadora, la tableta, el teléfono o ven televisión.
- ▶ Hable con el departamento de parques o de salud local para saber dónde puede encontrar lugares seguros para hacer ejercicio y obtener alimentos saludables.



Cosas importantes para recordar:

- ▶ Hágase la prueba para la diabetes de 6 a 12 semanas después del nacimiento de su bebé.
- ▶ Tome pasos para disminuir su probabilidad de desarrollar diabetes haciendo más ejercicio y eligiendo alimentos saludables para volver a tener un peso adecuado.
- ▶ Ayude a sus hijos a estar sanos y reducir su probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes

1-888-693-6337, TTY: 1-866-569-1162 • www.diabetesinformacion.org

Agradecemos a la Dra. Francine R. Kaufman, Profesora Emérita de Pediatría y Comunicación en la Universidad de California del Sur y médico en el Hospital Infantil de Los Ángeles, por su ayuda en revisar esta publicación.

El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes (NDEP) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos es un programa conjunto de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y de los Centros para el Control y las Prevención de Enfermedades (CDC), con el apoyo de más de 200 organizaciones asociadas.



NIH Publicación No. 14-6019(S) | NDEP-89

Revisada en abril del 2014

El NIDDK imprime en papel reciclado y con biotinta.

Prediabetes y diabetes

Es importante saber qué puede hacer para ayudarle a conocer los problemas a largo plazo y reducirlos.



¿Cuál es la diferencia entre la prediabetes y la diabetes?

La diferencia entre la prediabetes y la diabetes reside en el nivel de glucosa en la sangre (azúcar en la sangre). La prediabetes se produce cuando sus niveles de glucosa en la sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos como para ser diagnosticados como diabetes tipo 2. Consulte la información con viñeta de la página 2 para ver los niveles.

¿Qué está sucediendo en su cuerpo?

Una afección llamada resistencia a la insulina aumenta el riesgo de padecer tanto prediabetes como diabetes tipo 2. La insulina es una hormona que ayuda a que el azúcar de los alimentos pase de la sangre a las células del organismo. Las células necesitan azúcar (glucosa) para tener energía. El azúcar puede provenir de alimentos y bebidas dulces, como caramelos, pasteles y refrescos, o de carbohidratos como fruta, pan, arroz, pasta y leche.

Con la resistencia a la insulina, su cuerpo produce insulina, pero no responde a ella ni la utiliza de forma eficaz, por lo que la glucosa puede acumularse en la sangre. La mayoría de las personas con resistencia a la insulina no son conscientes de que la tienen. La buena noticia es que si las personas se enteran de forma temprana que tienen resistencia a la insulina, pueden retrasar la progresión hacia la diabetes tipo 2. Consulte el cuadro de la página 2 para descubrir cómo ayudar a reducir el riesgo.

¿Quién está en riesgo?

Estos son algunos de los factores de riesgo de la prediabetes y la diabetes:

- Tener sobrepeso o tener obesidad
- Tener 35 años o más
- Tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2
- Realizar actividad física menos de 3 veces por semana
- Tener antecedentes de diabetes gestacional
- Tener síndrome de ovario poliquístico
- Pertenecer a un grupo étnico con alto riesgo de diabetes, como nativo americano, afroamericano, hispano/latino, isleño del Pacífico o asiático americano

Es importante que hable de sus factores de riesgo con su médico. Si cree que puede estar en riesgo de padecer prediabetes, acuda a su médico para que le haga las pruebas.

La insulina funciona como una llave, que desbloquea las puertas de las células del cuerpo para dejar que entre la glucosa en la sangre. Una vez que las puertas de las células se abren, la glucosa puede moverse de la sangre a las células, que es donde debe permanecer. Una vez dentro de las células, la glucosa proporciona energía al cuerpo.

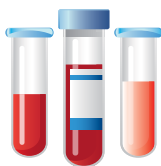


Prediabetes y diabetes

¿Cómo se diagnostica la prediabetes?

Puede tener prediabetes sin tener síntomas. Las pruebas de detección de prediabetes o diabetes tipo 2 deben comenzar a los 35 años, pero pueden realizarse antes en personas con ciertos factores de riesgo de diabetes. Esto se puede hacer con una de las siguientes pruebas:*

- **Prueba de glucosa plasmática en ayunas (GPA):** mide la glucosa en la sangre cuando no ha comido nada durante al menos 8 horas.



Prediabetes: de 100 a 125 mg/dl

Diabetes: 126 mg/dl o más

- **Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG):** mide cómo el organismo mueve el azúcar de la sangre a los tejidos como los músculos y la grasa. Las mediciones se realizan después de no haber comido durante al menos 8 horas y 2 horas después de haber bebido 75 g de glucosa proporcionada por un médico o laboratorio.

Prediabetes: de 140 a 199 mg/dl

Diabetes: 200 mg/dl o más

- **A1C:** mide la media de glucosa en la sangre estimada durante los últimos 3 meses.

Prediabetes: de 5.7 % a 6.4 %

Diabetes: 6.5 % o más

Su médico buscará estos valores para diagnosticar la prediabetes y la diabetes.

*Los valores que se muestran son para personas no embarazadas.
American Diabetes Association. Standards of care in diabetes—2024.
Diabetes Care. 2024;47(suppl 1):S1-S314.

¿Cómo puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 si tiene prediabetes?

Es importante comer de forma saludable y mantenerse físicamente activo. Perder peso es la mejor manera de evitar desarrollar diabetes tipo 2 si tiene sobrepeso u obesidad. Hable con su médico sobre cuál debería ser su peso objetivo.

Si tiene prediabetes, debe realizarse controles de glucosa en la sangre anualmente. Según la Asociación Americana de Diabetes (American Diabetes Association, ADA), si sus niveles de glucosa en la sangre son normales, debe realizarse un control cada 3 años o con mayor frecuencia si su médico lo recomienda.

La prediabetes no se convierte automáticamente en diabetes tipo 2. Puede tomar medidas para reducir su riesgo.

La ADA dice que para reducir su riesgo de padecer diabetes tipo 2, es necesario:

- Perder solo el 7 % del peso corporal (o 15 libras si pesa 200 libras)
- Hacer actividad física moderada (como caminar rápido) durante 30 minutos al día, 5 días a la semana
- Dejar de fumar



Visite espanol.diabetes.novocare.com para obtener recursos adicionales e información útil. Apunte la cámara de su teléfono inteligente al código QR para acceder rápidamente al sitio web en su teléfono.



Escanéame

Novo Nordisk Inc. autoriza la reproducción de este artículo con fines educativos y sin ánimo de lucro solo con la condición de que el artículo se mantenga en su formato original y que se muestre el aviso de derechos de autor. Novo Nordisk Inc. se reserva el derecho de revocar este permiso en cualquier momento.

NovoCare® es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

Novo Nordisk es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

© 2024 Novo Nordisk Impreso en EE. UU. US24PAT00012 Junio de 2024

espanol.diabetes.novocare.com

